

AvPD vs SAD — różnice

SAD = lęk **przed sytuacjami** (performans). AvPD = wstyd **bycia sobą** (tożsamość). Chambless 2008: nakładanie 40–60%. Krótka CBT na SAD nie wystarcza dla AvPD.

CZAS: 10 min **Diagnostyka** **ŹRÓDŁO:** Chambless i wsp. (2008); Eikenaes i wsp. (2015)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz cztery kluczowe różnice AvPD vs SAD (sekcja 01). **2** · Zrozumiesz, dlaczego rozróżnienie **kieruje do innego protokołu** (sekcja 02). **3** · Sprawdzisz, który profil bardziej pasuje do Ciebie (sekcja 03). **4** · Poznasz pytanie diagnostyczne, które różnicuje (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

AvPD i SAD nakładają się w **40-60%** (Chambless i wsp. 2008, metaanaliza), ale różnica fenomenologiczna jest *fundamentalna*: SAD to lęk **PRZED konkretnymi sytuacjami**, AvPD to wstyd **bycia sobą** — niezależnie od sytuacji. Eikenaes i wsp. (2015): AvPD wykazuje istotnie wyższe wyniki na skalach *identity disturbance* i *chronic emptiness* niż czysty SAD. Kluczowe różnice: SAD = ego-dystoniczne („ten lęk jest *irracjonalny*”); AvPD = ego-syntoniczne („naprawdę **jestem** nieadekwatny”). SAD reaguje szybciej na CBT (12–16 sesji, Heimberg, Clark). AvPD wymaga 1–3 lat terapii schematów + CBT + CFT. Klinicysta widzi unikanie społeczne, diagnozuje SAD — pacjent przechodzi 16 sesji, lęk maleje, ale wciąż mówi: „*nadal jestem wadliwy*”. Korekta lęku ≠ korekta tożsamości.

01 Cztery kluczowe różnice

1 · CO BUDZI LĘK

SAD: sytuacje performatywne (prezentacje, jedzenie przy ludziach, randka).

AvPD: relacje i bliskość. „Jestem wadliwy/-a, odrzuca mnie *gdy mnie poznają*”.

2 · EGO-DYSTONICZNE VS SYNTONICZNE

SAD: „*wiem, że ten lęk jest irracjonalny*”. Lęk obcy „prawdziwemu ja”.

AvPD: „*naprawdę jestem nieadekwatny*”. Wstyd jest tożsamością.

3 · BEZPIECZNE WYSPY

SAD: ma „bezpieczne wyspy” (dom, bliscy). Wstyd *znika*, gdy w komforcie.

AvPD: *nie ma* bezpiecznych wysp. Wstyd jest **chroniczny**, działa nawet w samotności.

4 · REAKCJA NA TERAPIĘ

SAD: 12–16 sesji CBT (Heimberg, Clark) — istotna poprawa.

AvPD: 1–3 lata terapii schematów + CBT + CFT (Bamelis 2014: $d \approx 1,0$).

Mechanizm: SAD aktywuje się w *specyficznych wyzwalaczach* (publiczne mówienie, jedzenie przy ludziach). AvPD ma **chroniczne tło wstydu**, na którym sytuacje są tylko *zaostreniami*. Pacjent z czystym SAD opowiada o sobie chętnie — pacjent z AvPD często milknie lub mówi „*nie wiem*”, i to jest klinicznie znaczące.

02 Inny protokół, inne ramy czasowe

SAD — 12–16 sesji CBT

Heimberg/Clark · hierarchia ekspozycji · restrukturyzacja

AvPD — 1–3 lata · terapia schematów + CBT + CFT

Bamelis 2014: $d \approx 1,0$ — praca z tożsamością, schematem defektywności, wstydem

Konsekwencja diagnozy: klinicysta widzi unikanie społeczne i bez dodatkowej diagnostyki zakłada SAD. Krótka CBT z hierarchią ekspozycji obniża lęk sytuacyjny — ale pacjent z AvPD po 16 sesjach mówi: „przeszłem przez prezentację, nikt nie wyśmiał — **ale nadal jestem wadliwy**”. Korekta lęku $\neq$ korekta tożsamości. Stąd waga diagnostyki różnicowej *na początku*.

03 Mój profil — sprawdź u siebie

CO BUDZI MÓJ LĘK?

— sytuacje (SAD) czy relacje (AvPD)?

CZY MAM „BEZPIECZNE WYSPY”?

— miejsca/osoby gdzie wstyd znika

CZUJĘ, ŻE MÓJ LĘK JEST IRRACJONALNY?

— SAD: *tak*; AvPD: „*nie, to fakt*”

KIM JESTEM, GDY NIKT NIE PATRZY?

— odpowiedź czy „*nie wiem*”?

04 Pytanie diagnostyczne

„Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy?”

Pacjent z czystym SAD opowiada o sobie — hobby, marzenia, charakter. Lęk jest na zewnątrz, tożsamość — w środku.

Pacjent z AvPD często **milknie**, albo odpowiada: „*nie wiem*”. Tożsamość jest *pochłonięta* przez wstyd — nie ma „ja” poza poczuciem defektywności.

To rozróżnienie jest klinicznie znaczące — kieruje do innego protokołu terapii (CBT vs ST + CBT + CFT) i innych ram czasowych (16 sesji vs 1–3 lat).

Klucz: nakładanie 40–60% (Chambless 2008) nie oznacza, że to to samo. Eikenaes 2015: AvPD różni się od czystego SAD wymiarem tożsamościowym — wyższe wyniki *identity disturbance* i *chronic emptiness*. SAD = lęk PRZED sytuacjami (performans); AvPD = wstyd BYCIA SOBĄ (tożsamość). Konsekwencja: **inny protokół, inne ramy czasowe**. Krótka CBT na SAD obniża lęk sytuacyjny, ale schemat defektywności AvPD *pozostaje nietknięty*. Bamelis 2014: terapia schematów w AvPD osiąga $d \approx 1,0$ — ale w protokole 50+ sesji. *Nie mniej, nie szybciej*. Diagnoza różnicowa otwiera dostęp do skutecznego leczenia.